Trombectomía en ictus leve por oclusión de gran vaso (MILD-MT): ¿un NIHSS bajo justifica no intervenir?

Liu J, Yi T, Xing P, et al.; MILD-MT Investigators. Trial of Endovascular Therapy for Mild Stroke with Large-Vessel Occlusion. *N Engl J Med*. 2026 (publicado en línea el 23 de octubre de 2026). doi:10.1056/NEJMoa2609149

Versión 1.0 · Revisado el 30 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Aún no, pero mueve la aguja
Primer ECA positivo en este grupo. Aplica a pacientes muy seleccionados por perfusión; falta replicarlo fuera de China y con más trombólisis.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Sólido, con límites
Efecto grande y consistente en desenlaces secundarios, evaluación cegada del desenlace; abierto, cofinanciado por un fabricante de dispositivos y con población muy particular.

CUIDADO AL INTERPRETAR
No es "todo ictus leve"
Solo NIHSS <6 con ≥50 ml de tejido en riesgo, núcleo ≤50 ml, ≤80 años y ≤24 h; en ~2/3 la oclusión era por aterosclerosis intracraneal.

En 30 segundos. ECA abierto con evaluación cegada del desenlace en 26 centros de China: 300 pacientes de 18 a 80 años con ictus leve (NIHSS <6) por oclusión de carótida intracraneal, M1 o M2, núcleo ≤50 ml y tejido en riesgo ≥50 ml en perfusión, dentro de 24 h, se asignaron a **trombectomía + tratamiento médico** o **tratamiento médico solo**. A 90 días, mRS 0–1: **69.4 % vs 50.0 %** (OR 2.32; IC 95 % 1.41 a 3.81); diferencia absoluta 19.7 puntos, **NNT 6**. Hemorragia sintomática 2.1 % vs 1.9 %; cualquier hemorragia 18.9 % vs 6.8 %; complicaciones graves del procedimiento 13.2 %. El deterioro neurológico temprano bajó de 31.4 % a 13.9 %.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Del OR al paciente: por qué el OR exagera la magnitud cuando el desenlace es frecuente y cómo pasar a diferencia absoluta y NNT; qué es un diseño PROBE (abierto con desenlace cegado); cómo afecta el rescate en el grupo control al análisis por intención de tratar, y por qué los subgrupos con IC que cruzan 1 no demuestran "ausencia de efecto".

1 La pregunta clínica (PICO)

POBLACIÓN	18–80 años, mRS previo 0, ictus isquémico con **NIHSS <6** por oclusión de **carótida intracraneal o cerebral media (M1 o M2)**, ASPECTS ≥6, **núcleo ≤50 ml y mismatch ≥50 ml** en perfusión automatizada (Tmax >6 s menos núcleo), ≤24 h desde el inicio o última vez visto bien. Mediana de edad 65–68 años; NIHSS mediano 4; M1 en ~66 %; núcleo mediano 1.5–1.8 ml y mismatch mediano 104 ml; aterosclerosis intracraneal como causa en ~58 %. Tiempo mediano a la aleatorización: 8.2–8.7 h.
INTERVENCIÓN	Trombectomía (stent retriever, aspiración, angioplastia o stent según el intervencionista) + tratamiento médico. Punción a una mediana de 0.8 h de la aleatorización; reperfusión eTICI 2b–3 en 93.8 %.
COMPARADOR	Tratamiento médico según la guía china (trombólisis IV 35.3 % vs 25.0 % en el grupo de trombectomía; antiagregantes 84 %). Se permitía trombectomía de rescate ante deterioro neurológico.
DESENLACE PRINCIPAL	mRS 0–1 (sin síntomas o sin discapacidad significativa) a 90 días, adjudicado por un comité cegado con entrevistas grabadas.

2 Diseño

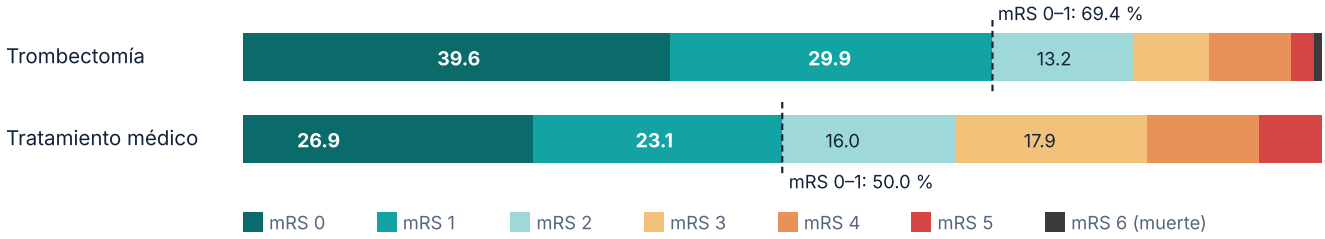
TIPO	ECA multicéntrico, abierto, con evaluación cegada del desenlace (PROBE), 1:1, estratificado por centro y sitio de oclusión. 26 centros de alto volumen en China (enero 2024 a octubre 2025).
TAMAÑO	300 pacientes para 80 % de poder, suponiendo 67.5 % vs 51.0 % de mRS 0–1. Un análisis intermedio con 150 pacientes no cruzó el límite de detención. Sin pérdidas en el desenlace primario.
ANÁLISIS	Intención de tratar modificada (excluye 4 que retiraron el consentimiento). Cochran-Mantel-Haenszel; regresión logística de efectos mixtos. Secundarios y subgrupos sin ajuste por multiplicidad.
FINANCIAMIENTO	Fujian Medical University Union Hospital, Beijing Health Promotion Association y MicroPort NeuroTech (fabricante del stent retriever recomendado); según los autores, los financiadores no participaron en el diseño ni en el análisis.

3 Resultados

EFICACIA A 90 DÍAS	TROMBECTOMÍA (N = 144)	MÉDICO (N = 156)	EFECTO (IC 95 %)
mRS 0–1 (primario)	**69.4 %**	**50.0 %**	**OR 2.32 (1.41 a 3.81)**; diferencia 19.7 puntos (8.4 a 30.9); NNT 6
mRS 0–2 (independencia funcional)	82.6 %	66.0 %	OR 2.68 (1.49 a 4.81)
Desplazamiento de la escala mRS (OR común de peor discapacidad)	—		0.48 (0.31 a 0.73)
Barthel 95–100	83.3 %	69.9 %	OR 2.18 (1.22 a 3.88)
Cambio del NIHSS a 6–8 días (mediana)	−2.0	−1.0	−1.32 (−2.22 a −0.42)

SEGURIDAD	TROMBECTOMÍA	MÉDICO	EFECTO (IC 95 %)
Hemorragia intracraneal sintomática a 48 h	2.1 % (3)	1.9 % (3)	OR 1.27 (0.21 a 7.94)
Cualquier hemorragia intracraneal a 48 h	18.9 %	6.8 %	OR 3.20 (1.48 a 6.93)
Deterioro neurológico temprano (7 días)	13.9 %	31.4 %	OR 0.36 (0.20 a 0.64)
Complicaciones graves del procedimiento	13.2 % (disección 5.6 %, HSA 2.8 %, embolia a territorio nuevo 2.1 %)	—	—
Muerte a 90 días	0.7 % (1)	0	—
Trombectomía de rescate	—	10.9 % (17); 41 % de ellos con mRS 0–1	—

Escala de Rankin modificada a 90 días (% de pacientes)



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de la tabla 2 del artículo; no reproduce figuras originales.

4 Cómo leer estos resultados

- **OR 2.32 no es "el doble de beneficio".** DATO DEL ARTÍCULO Con un desenlace tan frecuente (50 % en el control), el OR exagera la impresión de efecto. Lo útil es la **diferencia absoluta: 19.7 puntos, NNT 6**. INTERPRETACIÓN Tratar a 6 pacientes como estos para que uno más quede sin discapacidad es un efecto grande para una intervención aguda.
- **El mecanismo probable es evitar el deterioro.** El deterioro temprano bajó de 31.4 % a 13.9 %. Un NIHSS bajo con oclusión de gran vaso depende de colaterales que pueden fallar; el tejido en riesgo (mediana 104 ml) es lo que se protege.
- **El rescate en el control juega en contra de la trombectomía.** 10.9 % del grupo médico recibió trombectomía de rescate y se analizó en su grupo original (intención de tratar). INTERPRETACIÓN Esto tiende a acercar los resultados de los grupos; aun así, la diferencia fue grande.
- **Seguridad: dos lecturas.** La hemorragia sintomática fue igual, pero la hemorragia de cualquier tipo casi se triplicó (en gran parte radiológica, según los autores, por reperfusión y heparina en dosis bajas) y 1 de cada 8 tuvo una complicación grave del procedimiento.
- **Población peculiar.** ~58 % aterosclerosis intracraneal y casi 70 % del grupo de trombectomía recibió tratamiento de rescate de la estenosis (angioplastia o stent). INTERPRETACIÓN En poblaciones con más oclusiones embólicas, el beneficio y los riesgos pueden ser distintos.
- **Subgrupos.** En ≤6 h (OR 1.37; 0.51 a 3.63), con trombólisis (1.42; 0.51 a 3.92), con NIHSS 0–3 (1.61; 0.75 a 3.48) o con mismatch ≤70 ml (1.60; 0.54 a 4.75) los IC cruzan 1. El estudio no tuvo poder para subgrupos: no demuestran ausencia de efecto, pero tampoco permiten extrapolar con confianza.

- **Supuesto de odds proporcionales.** El análisis ordinal (OR común 0.48) no cumplió el supuesto; los autores reportan un modelo parcial en el suplemento. El desenlace primario binario no depende de ese supuesto.

CONCEPTO CLAVE · DEL OR AL NNT

INTERPRETACIÓN El OR compara momios (69.4/30.6 = 2.27 frente a 50/50 = 1.00), no proporciones. Cuando el evento es raro, OR y riesgo relativo se parecen; cuando es frecuente, como aquí, el OR se aleja de 1 más que el RR (69.4/50.0 = 1.39). Para decidir en la cama del paciente, convierte a diferencia absoluta (19.7 puntos) y NNT (≈6), y compáralo con el daño: complicación grave del procedimiento en 13 de cada 100.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Desenlace	mRS adjudicado por comité cegado con entrevistas grabadas; sin datos faltantes del primario.	Confirmado
● Consistencia	Todos los desenlaces funcionales y el deterioro temprano van en la misma dirección.	Confirmado
● Diseño abierto	Tratamiento conocido por pacientes y equipo; puede influir en cuidados y en la decisión de rescate.	Dato del artículo
● Trombólisis baja y desbalanceada	Solo un tercio recibió trombólisis (25.0 % vs 35.3 %); los autores reconocen que puede haber afectado el efecto.	Reconocido por los autores
● Generalización	100 % pacientes chinos (Han), alta aterosclerosis intracraneal, centros de alto volumen; ≤80 años, ≤24 h y mismatch ≥50 ml.	Reconocido por los autores
● Financiamiento	Cofinanciado por el fabricante del stent retriever recomendado; declaran que no participó en diseño ni análisis.	Dato del artículo
● Riesgo del procedimiento	Complicaciones graves en 13.2 % y más hemorragia de cualquier tipo.	Confirmado

Pregunta de repaso: mujer de 62 años, NIHSS 3 por afasia leve, 7 h de evolución, oclusión de M1, núcleo de 5 ml y 90 ml de tejido en riesgo en la perfusión, mRS previo 0. ¿Qué te dice MILD-MT?
Respuesta. Que es el tipo de paciente incluido en el ensayo y que, en ese contexto, la trombectomía aumentó la probabilidad de quedar sin discapacidad (NNT ≈6) y redujo el deterioro temprano, sin más hemorragia sintomática pero con 13 % de complicaciones graves del procedimiento. Al ser un solo ensayo en población china con mucha aterosclerosis intracraneal, la decisión debe tomarse con neurointervención, considerando la disponibilidad, la experiencia del centro y las preferencias de la paciente. En el subgrupo con NIHSS 0–3 el IC cruzó 1.

¿Qué aprendí de medicina?

- NIHSS bajo + oclusión de gran vaso + mismatch grande: la trombectomía mejoró el pronóstico.
- El beneficio parece venir de evitar el deterioro temprano.
- Hemorragia sintomática similar; complicaciones del procedimiento 13 %.
- La perfusión es clave para seleccionar.

¿Qué aprendí de investigación?

- Con desenlaces frecuentes, el OR exagera: usa diferencia absoluta y NNT.
- PROBE: abierto, pero con desenlace cegado.
- El rescate en el control diluye el efecto en intención de tratar.
- Subgrupo con IC que cruza 1 ≠ "no funciona".

6 Referencias

1. Liu J, Yi T, Xing P, et al. Trial of Endovascular Therapy for Mild Stroke with Large-Vessel Occlusion. N Engl J Med. 2026 (publicado en línea el 23 de octubre de 2026). doi:10.1056/NEJMoa2609149

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.